

SEMANA 1: Método SOAP

→ S: **subjetivo** Motivo do atendimento, anamnese, problema(s), sentimentos.

→ O: **objetivo** Dados do exame físico e/ou resultados dos exames complementares.

→ A: **avaliação** Hipóteses diagnósticas e problemas evidenciados na consulta (ex.: HAS, DM).

→ P: **plano** Proposta terapêutica elaborada: medicações prescritas, solicitações de exames complementares, orientações realizadas, encaminhamentos pendências para o próximo atendimento. SEMANA 2: PROTOCOLO SPIKES

→ S: Setting up e - Procure por um lugar calmo e que permita que a conversa seja particular. - Mantenha um acompanhante com seu paciente. - Sente-se e procure não ter objetos entre você e seu paciente. - Escute atentamente o que o paciente diz.

→ P: Perception Procure saber o que o paciente já sabe do que está acontecendo. Procure usar perguntas abertas. (ex.: o que você acha que está acontecendo?; você acha que é algo grave?)

→ I: Invitation Identifique até onde o paciente quer saber do que está acontecendo, se quer ser totalmente informado ou se prefere que um familiar tome as decisões por ele.

(ex.: os resultados não saíram como o esperado, você gostaria que eu os explicasse?; Você é o tipo de pessoa que gosta de saber exatamente o que está acontecendo?)

→ K: Knowledge

- Introduções como “infelizmente não trago boas notícias” podem ser um bom começo.

- Use sempre palavras adequadas ao vocabulário do paciente.

- Use frases curtas e pergunte, com certa frequência, como o paciente está e o que está entendendo.

→ E: Emotions Aguarde a resposta emocional que pode vir, dê tempo ao paciente, ele pode chorar, ficar em silêncio, em choque. Mantenha sempre uma postura empática.

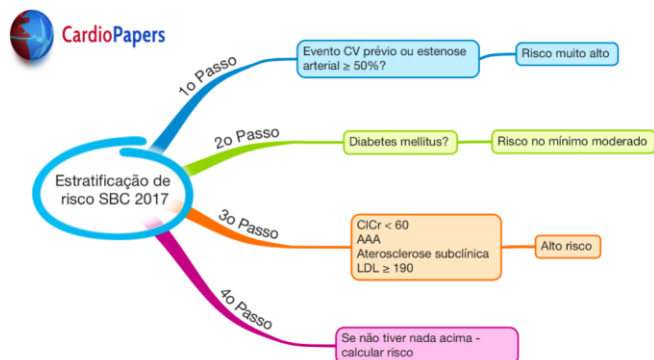
(ex.: Sei que as notícias não saíram como o esperado, sinto muito.)

→ S: Strategy and Summary Abordar um plano ou tratamento, curativo ou não. Pergunte se o paciente apresenta alguma dúvida.

1. Apresentou-se ao paciente e o cumprimentou (Nome, função e convidou o paciente a se sentar)
2. Perguntou se gostaria que algum familiar ou amigo participasse do atendimento
3. Indagou sobre o que o paciente sabia sobre o seu caso até o momento
4. Avisou que más notícias estavam por vir para diminuir o choque da transmissão das notícias
5. Fez escuta ativa (Contato visual, expressão facial, vocalizações ou gestos demonstrando interesse e respeito)
6. Avaliou o quanto o paciente quer saber
7. Informou o resultado de maneira adequada (Linguagem clara e acessível)
8. Forneceu a informação pouco a pouco
9. Conferiu periodicamente a compreensão do paciente
10. Fez o silêncio necessário para a reação do paciente
11. Ofereceu conforto ao paciente
12. Manteve as esperanças do paciente
13. Foi empático com o paciente e observou suas emoções
14. Fez explicação curta com as informações necessárias: possibilidade de terapia
15. Fez explicação curta com as informações necessárias: possibilidade de cura
16. Colocou-se à disposição para posteriores dúvidas
17. Discutiu a marcação de consulta de retorno
18. Não cometeu erros: minimizou a gravidade (Insistindo em apresentar o “lado bom” da situação ou diminuindo o problema)
19. Não cometeu erros: evitação (não adiou ou evitou a comunicação)

SEMANA 3 e 4: ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO CARDIOVASCULAR E IC

*Olhar calculadora SBC!



1. Mãos: - Aracnodactilia: dedos das mãos e dos pés anormalmente longos e delgados, característicos da Síndrome de Marfan, que está associada ao prolapso da valva mitral/aórtica e a dissecção da aorta. - Sinal da Janela: baqueteamento digital que envolve o inchaço do tecido mole da falange que está associado a várias doenças cardiovasculares. Em pacientes com baqueteamento digital a janela é perdida.

2. Pressão Venosa Jugular: Fornece uma medida indireta da pressão venosa central. Isso é possível porque a veia jugular interna (VJI) se conecta ao átrio direito sem nenhuma válvula intermediária, resultando em uma coluna contínua de sangue.

- Posicione o paciente em posição semi-reclinada (a 45°).

- Peça ao paciente para virar a cabeça ligeiramente para a esquerda.

- Verifique se há evidências de VJI, passando entre a extremidade medial da clavícula e o lóbulo da orelha, sob a face medial do esternocleidomastóideo (pode ser visível logo acima da clavícula, entre as cabeças esternal e clavicular do esternocleidomastóideo. obs.: A VJI tem uma pulsação em forma de onda dupla, o que ajuda a diferenciá-la da pulsação da artéria carótida externa.

- Meça a JVP avaliando a distância vertical entre o ângulo esternal e o topo do ponto de pulsação da VJI (em indivíduos saudáveis, não deve ser maior que 3 cm).

3. Teste de refluxo hepatojugular

- O teste de refluxo hepatojugular envolve a aplicação de pressão no fígado enquanto se observa um aumento sustentado na JVP.

- Posicione o paciente em posição semi-reclinada (45°).

- Aplique pressão direta no fígado .

- Intimamente observar o IJV para um aumento.

- Em indivíduos saudáveis, esse aumento não deve durar mais do que 1-2 ciclos cardíacos (deve cair).

- Se o aumento em JVP for sustentado e igual ou superior a 4 cm, este é considerado um resultado positivo.

4. Edema

- Inspeção e palpe os tornozelos do paciente em busca de evidências de edema de pedal (associado a insuficiência ventricular direita).

5. Fatores de risco

- Hipertensão

- Infarto do miocárdio

- Válvulas cardíacas anormais

- Cardiomiopatia

- Histórico familiar de doença cardíaca.

- Diabetes

- Tabagismo

- Obesidade.

6. Critérios de Framingham (2M ou 1M e 2m)

A – Aumento da jugular: turgência jugular e re-fluxo hepatojugular.

B – B3.

C – Cardiomegalia.

D – Dispneia Paroxística Noturna (DPN) e ortopneia.

E – Edema Agudo de Pulmão (EAP)/Estertores pulmonares.

F – Furosemida: redução do peso (4,5 kg em 5 dias) com diurético.

Crítérios maiores	Crítérios menores
Dispneia paroxística noturna	Edema bilateral de tornozelos
Turgência jugular patológica	Tosse noturna
Crepitações pulmonares	Dispneia aos esforços
Cardiomegalia (raio X de tórax)	Hepatomegalia
Edema agudo de pulmão	Derrame pleural
Terceira bulha (galope)	Diminuição da capacidade funcional em 1/3 da máxima registrada previamente
Aumento da pressão venosa central (> 16 cm H ₂ O)	
Refluxo hepatojugular	
Perda de peso > 4,5 kg em 5 dias em resposta ao tratamento	
Para diagnóstico: 2 critérios maiores ou 1 maior e 2 menores que não possam ser atribuídos a outra patologia	

7. Classificação NYHA

Classe Funcional	Definição	Descrição geral
I	Ausência de sintomas	Assintomático (dispneia aos grandes esforços, como esperado para qualquer pessoa)
II	Sintomas com atividades habituais e limitação leve	Dispneia aos moderados esforços
III	Sintomas com atividades menos intensas que habituais e limitação importante	Dispneia aos pequenos esforços
IV	Sintomas com qualquer atividade e ao repouso	Dispneia ao repouso

8. Classificação AHA

Estágio	Descrição	Descrição
A	Sob risco de IC	Fator de risco para IC, sem doença estrutural nem sintomas
B	Pré-IC	Doença cardíaca estrutural, sem sintomas
C	IC	Sintomas de IC, atuais ou progressos
D	IC avançada	Sintomas refratários ao tratamento clínico. Requer intervenção especializada

SEMANA 5: REFERÊNCIA E CONTRARREFERÊNCIA

Referência compreende-se o trânsito do nível menor para o de maior complexidade. Inversamente, a contrarreferência compreende o trânsito do nível de maior para o de menor complexidade.

Ex.: Paciente queixa de dor torácica e cianose ao esforço, o médico da UBS tem como hipótese diagnóstica sopro sistólico após realizar ausculta no paciente. Sendo assim, encaminha (referência) paciente para um cardiologista. Após consulta com cardiologista, o paciente retorna ao médico da UBS para

apresentar conclusão diagnóstica e exames feitos pelo especialista.

SEMANA 6: SÍNDROME CORONARIANA AGUDA

1. Anamnese:

- Tempo: quando que iniciou a dor? Ela é contínua? Quando a dor começou o senhor estava fazendo o quê? Duração? (Fator precipitante).

- Intensidade: de 0 a 10

- Localização: onde começou? O senhor pode apontar para mim o local? A dor está migrando/espalhando para outro lugar (irradiando)?

- Qualidade da dor: esta dor está como? pressão? Fisgada? Aperto? Desconforto? Observar sinal de Levine.

- Sintomas relacionados: o senhor está sentindo mais alguma coisa junto? Falta de ar? Tontura? Náusea?

- Fatores de alívio ou de estímulo: quando essa dor surgiu o senhor estava fazendo o que? O que piora essa dor? Você já sentiu essa dor em outras ocasiões? Surge aos esforços habituais? Perguntar se fez alguma coisa para melhorar, em repouso melhora? O senhor tomou alguma medicação para essa dor?

2. Fatores de risco:

- História familiar de DAC prematura (familiar de 1º masculino antes dos 55 anos e do sexo feminino antes dos 65 anos);

- Idade: Homem > 45 anos ou mulher > 55 anos;

- Tabagismo;

- Hipercolesterolemia;

- Diabetes mellitus;

- Obesidade;

- Sedentarismo;

- Dieta pobre em frutas e vegetais;
- Estresse psicossocial;
- Artrite reumatoide.

Obs.: HAS – DM – dislipidemia – história familiar – tabagismo: 3 ou mais desses fatores em conjunto constituem um marcador independente prognóstico.

3. Classificação

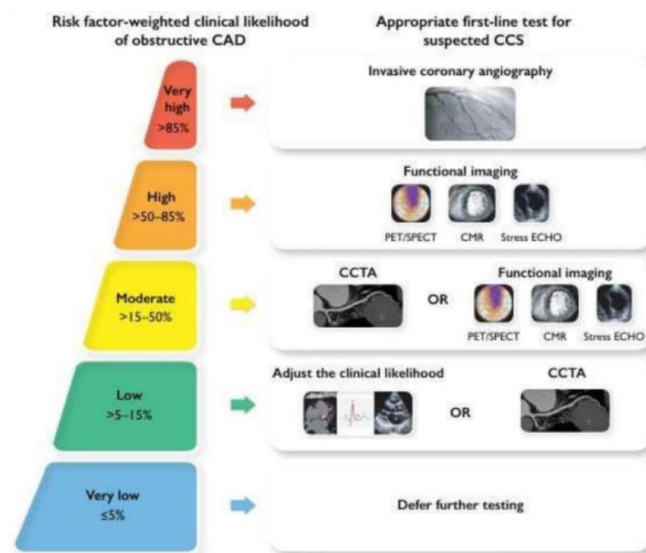
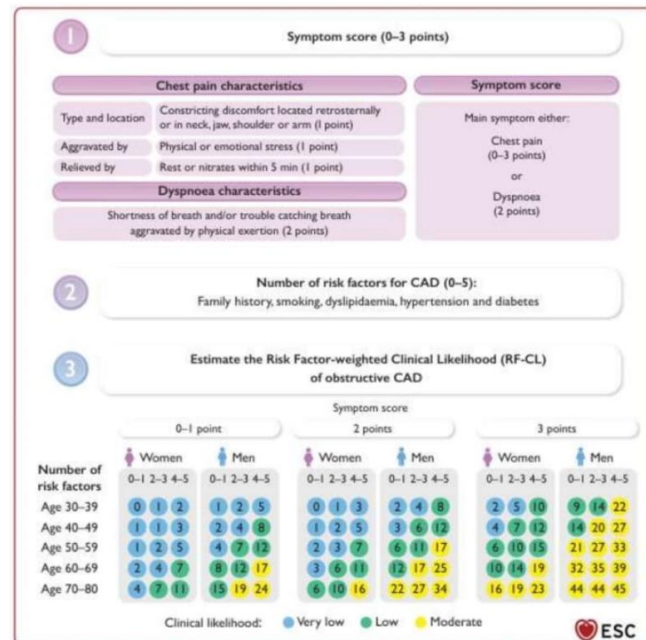
Angina típica (definitiva)	Atende a todas as 3 características a seguir: 1) Dor ou desconforto torácico subesternal 2) Provocado pelo esforço ou estresse emocional 3) Aliviado pelo repouso e/ou nitratos em poucos minutos
Angina atípica (provável)	Atende a 2 dessas características
Dor torácica não anginosa	Atende apenas a 1 ou nenhuma das características

- HEART SCORE

Letra	Componente	Descrição	Pontuação (0-2)
H	History	História clínica compatível com angina típica?	0 = pouco sugestiva 1 = moderadamente sugestiva 2 = fortemente sugestiva
E	ECG	Alterações no eletrocardiograma	0 = normal 1 = alterações inespecíficas 2 = depressão de ST significativa
A	Age	Idade	0 = <45 anos 1 = 45-64 anos 2 = ≥65 anos
R	Risk Factors	Fatores de risco cardiovasculares (ex: DM, HAS, dislipidemia, tabagismo, obesidade, história familiar, DAC conhecida)	0 = nenhum 1 = 1-2 fatores 2 = ≥3 fatores ou DAC documentada
T	Troponin	Valor da troponina comparado ao limite superior normal do laboratório	0 = normal 1 = 1-3x o limite 2 = >3x o limite

Pontuação Total	Categoria de Risco	Risco de MACE em 6 semanas	Conduta Sugerida
0-3	Baixo risco	~1-2%	Alta com acompanhamento ambulatorial
4-6	Risco intermediário	~12-16%	Observação, exames adicionais
7-10	Alto risco	~50-65%	Internação, tratamento intensivo

- Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC)



4. Exame físico:

- Sinais vitais
- Inspeção: paciente sudorético, angustiado, hipoxemia, cianose.
- PA: avaliar simetria
- Palpação de pulsos do MMSS e MMII, avaliar simetria e tônus
- Ausculta cardíaca: sopros, B4, ictus deslocado, B3
- Ausculta crepitantes
- pulmonar: estertores
- Extremidades: procurar sinais de insuficiência ventricular

Obs.: Sinais de maior gravidade e pior prognóstico: estertores pulmonares e B3, sinais de disfunção do VE, sopro.



6. Conduta: MONABC

- Morfina (alternativa de analgesia)
- Oxigenação
- Nitrato/nitroglicerina
- AAS
- Betabloqueador
- Clopidogrel (antiagregante plaquetário)
- Heparina (anticoagulante)

7. Tratamento:

- IAM com supra de ST e biomarcadores presentes: Se o tempo porta-balão for de até 90 minutos enviar para o cateterismo, se o local não tiver serviço de hemodinâmica, transferir o paciente desde que o tempo de locomoção até o procedimento não exceda 120 minutos. Com a impossibilidade do cateterismo, realizar o trombolítico: Ateplase e administrar junto enoxeparina.
- IAM sem supra de ST (eletro normal ou com infra/alterações de onda T), porém biomarcadores presentes: Paciente de risco intermediário – iniciar anticoagulação

(enoxeparina) Paciente de alto risco-acrescentar clopidogrel

- Angina instável: sem alterações no ECG e sem elevação de biomarcadores.

SEMANA 7: VALVOPATIAS

1. Estenose mitral

- Quadro clínico: palpitações, rouquidão (síndrome de Ortner) e todas as valvopatias podem evoluir com sintomas de IC (dispneia aos esforços, ortopneia, dispneia paroxística noturna, edema periférico) -> mau prognóstico.
- Exame físico: sopro diastólico em ruflar
- Diagnóstico: melhor ECO

TABELA 7.3 Classificação da estenose mitral

Estenose mitral	Gradiente médio transvalvar (mmHg)	Pressão sistólica arterial pulmonar (mmHg)	Área valvar (cm²)
Leve	< 5	< 30	> 1,5
Moderada	5-10	30-50	1,0-1,5
Grave	> 10	> 50	< 1,0

2. Estenose aórtica:

- Quadro clínico: tríade - dispneia, angina e síncope.
- Exame físico: sopro sistólico de ejeção.

3. Insuficiência aórtica:

- Exame físico: sopro diastólico aspirativo/protodiastólico; Sopro de Austin-Flint (estenose mitral relativa a uma insuficiência aórtica); sinal de Corrigan (pulso em martelo d'água), sinal de musset (movimentação da cabeça); sinal de muller (pulsção da úvula), sinal de quinke (pulsção da unha); sinal de Hill (diferença da PA dos MMII > 20mmHg em comparação com os MMSS).

4. Insuficiência mitral:

- Exame físico: sopro sistólico regurgitativo.

SEMANA 8: DAOP

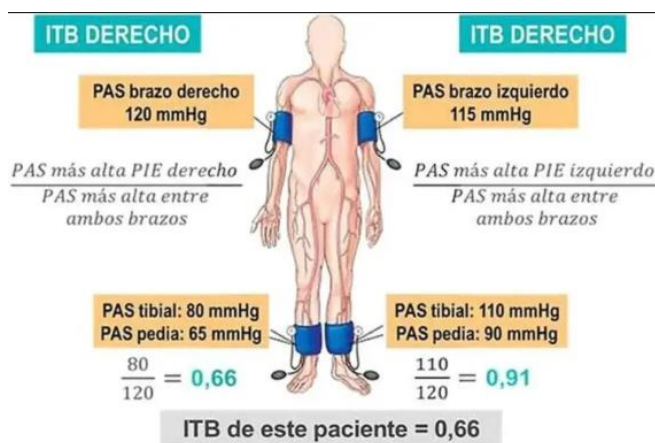
GRUPOS DE RISCO PARA DAOP (ACC/AHA)
Idade ≥ 70 anos.
Entre 50 e 69 anos com histórico de tabagismo ou diabetes.
Entre 40 e 49 anos com diabetes e pelo menos outro fator de risco para aterosclerose.
Sintomas nas pernas sugestivos de claudicação com esforço ou dor isquêmica em repouso.
Exame anormal de pulso na extremidade inferior.
Aterosclerose conhecida em outros locais (doença coronariana, carotídea, artéria renal...).

- manifestações clínicas

Assintomáticos	Úlceras ou gangrena
20-50%	Difícil cicatrização; Pele brilhante, tensa, perda de pelos
Membro ameaçado	
1-2%	
Envolve extensão e gravidade da ferida e presença de infecção	
Isquemia aguda: Tromboembolismo	Isquemia crônica: Estenoses
Dor nos MMII	
Claudicação	Dor atípica
10-35%	40-50%
Desconforto em grupo muscular induzido por exercício e aliviado com repouso	
Nádegas/quadril: aorto-iliaco Coxas: a. femoral Panturrilhas: a. femoral superficial ou a. poplítea Pés: a. tibial ou a. fibular	

- diagnóstico

→ ITB – Índice Tornozelo-Braquial:



Valor do ITB	Interpretação
> 1,30	Artérias não compressíveis (calcificadas) – comum em diabéticos e idosos
1,00 – 1,30	Normal
0,91 – 0,99	Limítrofe – pode ser normal ou início de DAP
0,41 – 0,90	Doença arterial periférica moderada a leve
< 0,40	Doença arterial periférica grave

→ Teste Ergométrico: Para pacientes com fatores de risco para DAOP e sintomas atípicos ou claudicação, mas com ITB normal.

→ Imagem vascular: Geralmente a imagem vascular não é necessária para estabelecer o diagnóstico de DAOP, no entanto pode ser indicada para diferenciá-la de outras doenças vasculares e para identificar o local do vaso acometido em caso de indicação de intervenção. A arteriografia com contraste é o padrão-ouro para avaliação do membro acometido. A radiografia simples de membros inferiores pode mostrar calcificação arterial em locais consistentes com DAOP, como nos pontos de ramificação arterial.

- Classificação de Rutherford:

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO RUTHERFORD	
Estágio 0	Assintomático
Estágio 1	Claudicação leve
Estágio 2	Claudicação moderada
Estágio 3	Claudicação grave
Estágio 4	Dor em repouso
Estágio 5	Úlcera isquêmica
Estágio 6	Úlcera isquêmica grave ou gangrena

- Classificação de Fontaine:

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO FONTAINE	
Estágio 1	Assintomático
Estágio 2	2a: Claudicação a distância >200m 2b: Claudicação a distância < 200m
Estágio 3	Dor noturna e/ou em repouso
Estágio 4	Úlcera isquêmica e/ou gangrena

- Classificação TASC II:

LESÕES TIPO A	LESÕES TIPO B
Estenose única ≤ 10cm de comprimento; Oclusão única ≤ 5cm de comprimento.	Múltiplas lesões (oclusões ou estenoses) ≤ 5cm cada; Oclusão ou estenose única ≤ 15cm sem envolver artéria poplítea infragenicular; Lesões únicas ou múltiplas na ausência de vasos tibiais contínuos melhorando o influxo para um by-pass distal; Oclusão muito calcificada ≤ 5cm de comprimento; Estenose poplítea única.
LESÕES TIPO C	LESÕES TIPO D
Múltiplas estenoses ou oclusões totalizando > 15cm com ou sem calcificação grave; Estenoses ou oclusões recorrentes que necessitam de tratamento após duas intervenções endovasculares.	Oclusão total crônica da artéria femoral comum ou superficial (> 20cm, envolvendo a artéria poplítea); Oclusão total crônica da artéria poplítea e vasos de trifurcação proximal.

- Tratamento:

→ Modificação dos fatores de risco (tabagismo, hiperlipidemia, hipertensão, hiperglicemia)

→ Prática de exercícios (mínimo de 45 a 60 minutos, pelo menos 3 vezes por semana, durante pelo menos 12 semanas. Durante cada sessão, um nível de exercício com intensidade suficiente para provocar claudicação deve ser alcançado)

→ Terapia farmacológica

AAS e estatinas é recomendado por diversas diretrizes por reduzir a mortalidade cardiovascular nos pacientes com DAOP. A terapia farmacológica específica da claudicação visa melhorar os sintomas e aumentar a distância da caminhada sem dor em pacientes com claudicação, principalmente se a modificação dos fatores de risco e exercícios físicos não forem eficazes e a revascularização não puder ser oferecida. Para pacientes com claudicação que limita o estilo de vida, pode ser realizado um ensaio terapêutico (3 a 6 meses) de Cilostazol ou Pentoxifilina.

→ Intervenção cirúrgica (Opção para pacientes significativamente incapacitados pela claudicação, naqueles refratários ao tratamento clínico, ou com dor em repouso, gangrenas ou úlceras. As opções incluem intervenção percutânea, desvio cirúrgico ou uma combinação das duas técnicas)

SEMANA 9: TROMBOEMBOLISMO PULMONAR

- Anamnese: dor torácica pleurítica, dispnéia aos esforços ou em repouso, hemoptise.

- Diagnóstico:

→ Escore de Wells

	Original	Simplificado
TVP ou TEP prévias	1,5 ponto	1 ponto
FC > 100 bpm	1,5 ponto	1 ponto
Imobilização (≥ 3 dias) ou cirurgia nas últimas 4 semanas	1,5 ponto	1 ponto
Hemoptise	1 ponto	1 ponto
Neoplasia maligna ativa	1 ponto	1 ponto
Sinais clínicos de TVP	3 pontos	1 ponto
Diagnóstico alternativo menos provável que TEP	3 pontos	1 ponto
Probabilidade clínica		
Baixa	0-1 ponto	—
Intermediária	2-6 pontos	—
Alta	> 6 pontos	—
TEP improvável	0-4 pontos	0-1 ponto
TEP provável	> 4 pontos	≥ 2 pontos

O **D-Dímero** é um marcador laboratorial que pode ser útil na exclusão de trombose venosa, pois níveis elevados indicam a presença de fibrinólise.

Em suma, na investigação inicial de TEP - NÃO FAZ EXAME DE IMAGEM COMO PRIMEIRA ETAPA!

- Primeiro - Faz Wells - Se for ≥ 2 ou TEP Provável = **FAZER ANGIOTOMOGRAFIA DE TÓRAX**
- Segundo - Faz Wells - Se for < 2 ou TEP Improvável = **FAZER D-DÍMERO** = SE D-DÍMERO FOR ALTO = **FAZER ANGIOTOMOGRAFIA DE TÓRAX**

O método diagnóstico considerado padrão ouro para a avaliação da TVP é a **Angiotomografia de Tórax**, que permite visualizar o fluxo sanguíneo e identificar refluxo venoso e obstruções. Achados sugestivos:

Cálculo do valor limite do D-Dímero:

- Em muitos laboratórios, o limite superior do D-dímero é definido como 500 ng/mL (ou 0,5 µg/mL) para adultos.
- Para pacientes acima de 50 anos, uma fórmula comum utilizada é:
Limite Superior = Idade × 10 ng/mL
- Assim, por exemplo, para um paciente de 70 anos, o limite superior seria: 70 × 10 = 700 ng/mL

→ Escore de Genebra

	Original	Simplificado
TVP ou TEP prévias	3 pontos	1 ponto
FC ≥ 95 bpm/75-94 bpm	5 pontos/3 pontos	2 pontos/1 ponto
Cirurgia ou fratura nas últimas 4 semanas	2 pontos	1 ponto

	Original	Simplificado
Hemoptise	2 pontos	1 ponto
Neoplasia maligna ativa	2 pontos	1 ponto
Dor unilateral em membro inferior	3 pontos	1 ponto
Dor à palpação profunda e edema unilateral em membro inferior	4 pontos	1 ponto
Idade > 65 anos	1 ponto	1 ponto
Probabilidade clínica		
Baixa	0-3 pontos	0-1 ponto
Intermediária	4-10 pontos	2-4 pontos
Alta	≥ 11 pontos	≥ 5 pontos
TEP improvável	0-5 pontos	0-2 pontos
TEP provável	≥ 6 pontos	≥ 3 pontos

- PERC Rule

Evitar a realização de exames desnecessários (como dímero D ou angiotomografia pulmonar) em pacientes com baixa probabilidade clínica de EP, desde que todos os critérios sejam negativos.

Como usar o PERC Rule:

1. Paciente com baixa probabilidade clínica de EP (ex: escore de Wells baixo)
2. Aplicar os 8 critérios PERC
3. Se TODOS forem negativos (0 pontos) → risco de EP é <2%, e não é necessário solicitar exames adicionais
4. Se qualquer critério for positivo, deve-se prosseguir com investigação (geralmente com dímero D)

Critério PERC	Interpretação
Idade < 50 anos	✔ Negativo se < 50 anos
FC < 100 bpm	✔ Negativo se < 100 bpm
SatO ₂ ≥ 95% em ar ambiente	✔ Negativo se ≥ 95%
Sem hemoptise	✔ Negativo se não presente
Sem uso recente de hormônio estrogênico	✔ Negativo se não usa
Sem cirurgia ou trauma significativo nos últimos 4 sem.	✔ Negativo se não ocorreu
Sem história prévia de tromboembolismo venoso (TEV)	✔ Negativo se nunca teve
Sem sinais clínicos de TVP (edema, dor unilateral)	✔ Negativo se exame físico normal

- Exames complementares:

→ ECG (taquicardia S1Q3T3); sinusal

→ ECO (sinais de disfunção de VD)

→ D-dímero (indicado em pacientes de baixa probabilidade pelo Wells – sua negatividade exclui TEP)

→ angioTC (indicado para pacientes de média/alta probabilidade).

- Conduta:

→ Se instável → ECO beira do leito, seguido de angioTC de emergência e trombólise química com alteplase.

→ Se estável → faz D-dímero se baixo risco e (se positivo ou se alto risco) faz angioTC, seguido de anticoagulação com rivaroxabana.

SEMANA 9: TUBERCULOSE

- Quadro clínico: febre, sudorese noturna, perda ponderal, inapetência e tosse há mais de três semanas.

- Exame físico:

→ Aparelho respiratório: MV reduzido, pode haver presença de crepitações, roncos ou sibilos.

- Diagnóstico: duas baciloscopias e/ou TRM-TB e/ou cultura + raio-x de tórax.

RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA DE TÓRAX	Geralmente normal, mas quando alterada pode apresentar adenopatia hilar, complexo de Ranke e nódulo de Ghon	Geralmente alterada, frequentemente nos lobos superiores, com cavidades e infiltrados. Na TC pode ter padrão de árvore em brotamento	Micronódulos difusos no parênquima pulmonar
-----------------------------------	---	--	---

- Tratamento:

→ Fase intensiva: isoniazida rifampicina + + pirazinamida + etambutol. Feito por 2 meses.

→ Fase de manutenção: rifampicina + isoniazida. Iniciado após a fase de ataque e dura, no mínimo, 4 meses, dependendo apresentação clínico tuberculose no paciente.

SEMANA 10: DPOC

- Quadro clínico: tosse crônica produtiva; dispneia aos esforços e infecção respiratória de repetição.

Obs.: Paciente com pouca exposição deve dosar alfa 1 antitripsina (se tiver deficiência realizar reposição subcutânea semanal).

- Exame físico:

→ MV reduzido

→ Ronco e sibilância

→ Bulhas hipofonéticas

→ Cianose

→ Pletora facial

→ Sinais de IC - casos graves

→ Hipersonoridade

→ Redução da expansibilidade

→ Tórax em tonel

- Anamnese/perguntas:

→ Qual a característica da tosse (seca/expectoração)?

→ Coloração da expectoração (caso haja).

→ Qual tempo de surgimento e como está a progressão (tem aumentado)?

→ Tosse é intermitente ou contínua na maior parte do dia?

→ Tem fator de melhora ou piora? (Decúbito, exercício, etc)

→ Sintomas associados? Febre, calafrios, sudorese, vômitos/náuseas, dispneia.

→ Faz uso de algum medicamento?

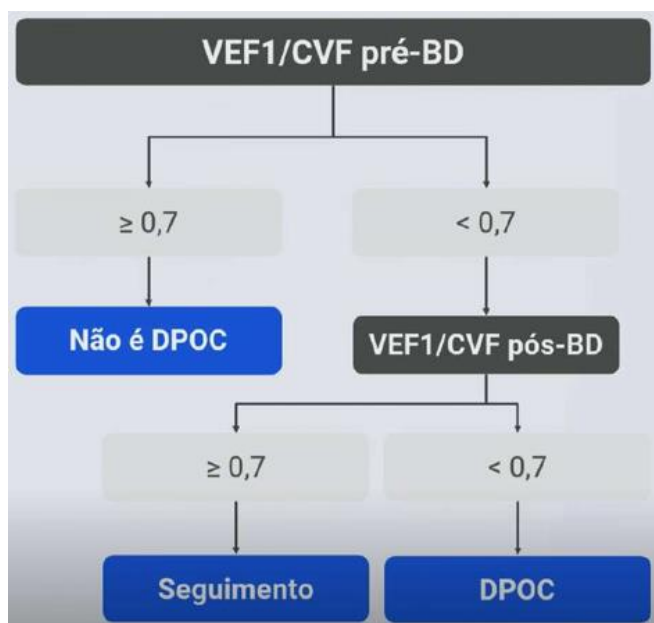
→ Tem alguma comorbidade (HAS, diabetes, hiperlipidemia, etc)?

→ É tabagista? Se sim, a quanto tempo e quantos maços ao dia?

→ Trabalha com oq? Fogão a lenha, exposto a agentes tóxicos, etc)

→ Alguém na família de 1º grau tem doenças pulmonares como tumor, bronquite, etc?

Diagnóstico: Espirometria

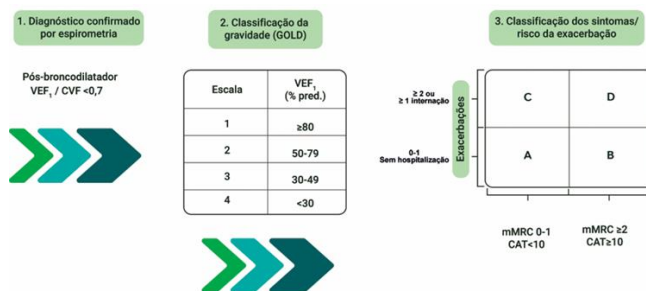


- Classificação de Gold:

Escala	VEF ₁ pós BD (% pred.)	Classificação
1	≥ 80	Leve
2	50–79	Moderado
3	30–49	Grave
4	< 30	Muito grave

Classificação de dispneia mMRC:

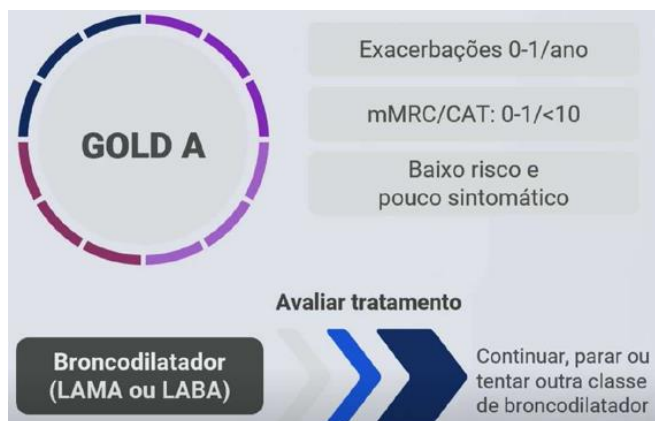
mMRC 0	Dispneia apenas aos exercícios extenuantes
mMRC 1	Dispneia ao correr no plano ou em inclinações leves.
mMRC 2	Caminha mais devagar que pessoas da mesma idade ou, quando anda no plano em seu próprio ritmo, tem que interromper a marcha para respirar.
mMRC 3	Interrompe a marcha após cerca de 100 metros ou após andar poucos minutos no plano.
mMRC 4	Dispneia que impede sair de casa ou vestir-se.



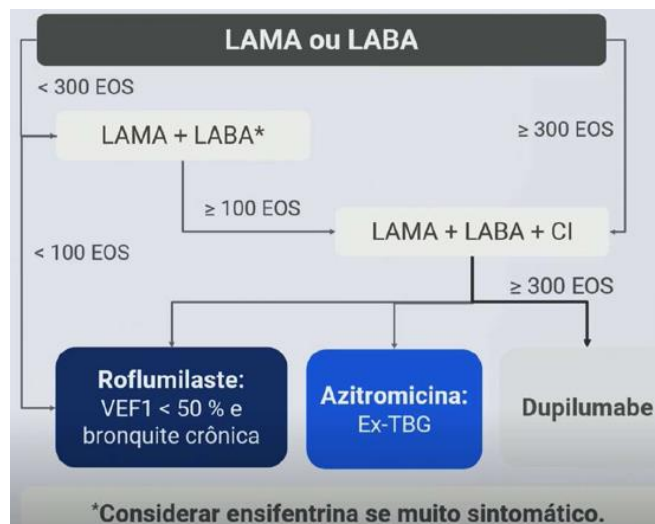
- Exames complementares:

→ Na Radiografia de Tórax - Retificação do diafragma e aumento do espaço retroesternal

- Tratamento:



Corticoide inalatório (CI) na DPOC	
Favorece o uso	Desfavorece o uso
Exacerbações	PNM frequentes
Eosinófilos ≥ 300	Eosinófilos < 100
Asma concomitante	História de tuberculose



*Considerar ensifentrina se muito sintomático.

SEMANA 11: PNEUMONIA E SÍNDROMES PLEURAIS

PNEUMONIA

BACTÉRIAS TÍPICAS E ATÍPICAS NAS PNEUMONIAS ADQUIRIDAS NA COMUNIDADE		
Microrganismos típicos	Sinais e sintomas	Exame físico
<i>Streptococcus pneumoniae</i> <i>Haemophilus influenzae</i> <i>Moraxella catarrhalis</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Streptococcus pyogenes</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> Anaeróbios	Febre alta Tosse com expectoração purulenta Dor torácica	Estertores crepitantes Frêmito tocoavocal aumentado Pectoriloquia
Microrganismos atípicos		
<i>Mycoplasma pneumoniae</i> <i>Chlamydia pneumoniae</i> <i>Legionella pneumophila</i>	Febre baixa Tosse seca Dor torácica	Estertores crepitantes Sibilos

-Diagnóstico:

A PAC manifesta-se como uma **doença aguda do trato respiratório inferior**, e os dados clínicos importantes para o diagnóstico são:

- ❶ **Tosse e 1 ou mais dos seguintes sintomas: expectoração, dispneia e dor torácica.**
- ❷ **Pelo menos 1 achado sistêmico:** confusão mental, cefaleia, sudorese, calafrios, dores musculares, febre (temperatura a partir de 37,8°C).
- ❸ **Achados focais no exame físico do tórax** (ausência de anormalidades não exclui o diagnóstico).
- ❹ **Alteração radiológica compatível**, na radiografia ou tomografia computadorizada de tórax.

A presença de **alteração radiológica nova** é importante para corroborar o diagnóstico de pneumonia, já que os sintomas são inespecíficos e podem estar presentes em infecções de vias aéreas superiores.

Em idosos, a ausência de febre e de sintomas respiratórios são preditores de risco aumentado de mortalidade, e a interpretação dos exames de imagem pode ser prejudicada pela existência de doenças associadas.

- Exames Complementares:

→ Radiografia de tórax sempre deverá ser solicitada quando disponível → complicações, extensão, diagnósticos diferenciais...

Pneumonia típica:

Infiltrados radiopacos irregulares;

Unilateral ou bilateral; Lobar → lobo inteiro consolidado;

Broncogramas aéreos → contraste entre o ar contido na via aérea e a consolidação peribrônquica.

Pneumonia atípica:

Infiltrados intersticiais (reticulares);

Encontrados de forma simétrica nas regiões peri-hilares;

Exames laboratoriais complementares e alterações esperadas na pneumonia típica e atípica		
Exame laboratorial	Pneumonia típica	Pneumonia atípica
Hemograma	Leucocitose Neutrofilia Desvio à esquerda (↑ bastonetes, ↑ metamielócitos, ↑ mielócitos) Leucopenia (pacientes mais graves)	Normal Leucocitose discreta Neutrofilia discreta
Proteína C reativa	Muito aumentada	Pouco aumentada
Procalcitonina	Muito alterada	Pouco alterada
Ureia	Aumentada (casos graves)	Normal
Sódio	Normal ou hiponatremia (se <i>Legionella sp.</i>)	Normal

- Classificação CURB-65:

Letra	Critério	Pontuação
C	Confusão mental (nova ou piora cognitiva)	1 ponto
U	Ureia > 50 mg/dL	1 ponto
R	Frequência respiratória ≥ 30 irpm	1 ponto
B	Pressão arterial sistólica < 90 mmHg ou diastólica ≤ 60 mmHg	1 ponto
65	Idade ≥ 65 anos	1 ponto

Pontuação	Gravidade	Conduta sugerida pela SBPT
0 – 1	Baixa	Tratamento ambulatorial
2	Moderada	Considerar internação hospitalar (enfermaria)
≥ 3	Alta	Internação hospitalar, considerar UTI (sobretudo se ≥ 4)

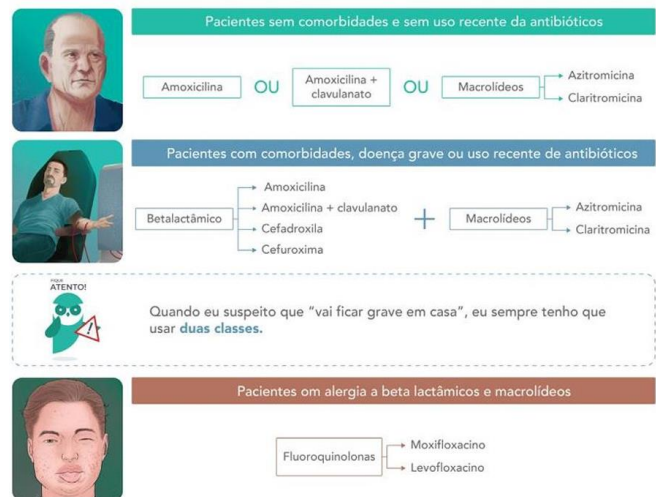
- Classificação CRB-65:

Letra	Critério
C	Confusão mental (novo estado)
R	Frequência respiratória ≥ 30 irpm
B	Pressão arterial sistólica < 90 mmHg ou diastólica ≤ 60 mmHg
65	Idade ≥ 65 anos

Pontuação	Risco de mortalidade	Conduta sugerida
0	Baixo (<1%)	Tratamento ambulatorial
1	Intermediário (2–3%)	Avaliar comorbidades, pode ser ambulatorial ou internação
≥ 2	Alto (>10%)	Internação hospitalar; considerar UTI se escore = 3–4

- Tratamento:

TRATAMENTO EMPÍRICO DA PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE (SBPT, 2018) PACIENTES AMBULATORIAIS



TRATAMENTO EMPÍRICO DA PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE (SBPT, 2018) PACIENTES INTERNADOS EM ENFERMARIA

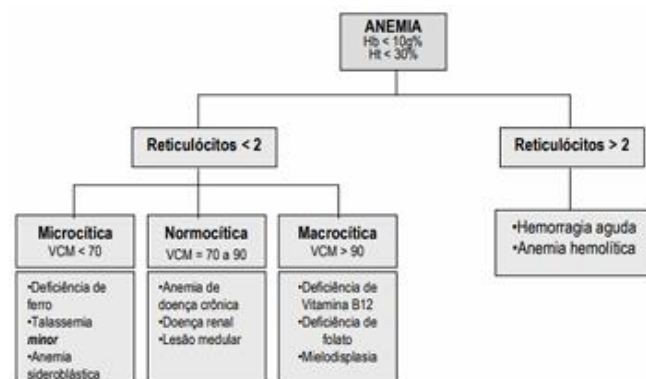


SÍNDROMES PLEURAIS

- Quadro clínico: falta de ar, tosse e dor torácica.

- Exame físico: MV abolido e crepitações difusas.

01	Descreveu as alterações da radiografia do tórax: Velamento homogêneo do hemitórax esquerdo; apagamento do seio costofrênico esquerdo; apagamento do seio cardiofrênico esquerdo. Sim (as 3) = 1,0 Sim (apenas 2) = 0,5 1 <u>OU</u> não descreveu = 0,0
02	Identificou as principais hipóteses diagnósticas (derrame pleural à esquerda <u>E</u> quilotórax). Sim (as duas) = 1,0 Sim (apenas uma) = 0,5 Não identificou = 0,0
03	Esclareceu que o quadro clínico ocorreu por lesão do ducto torácico, secundária à punção da veia subclávia esquerda, durante sua internação. Sim (resposta completa) = 1,0 Sim (apenas lesão do ducto torácico) = 0,5 Não esclareceu = 0,0
04	a) Esclareceu sobre a inexistência de medicação para tratamento do quadro. Sim = 0,5 Não = 0,0 b) Esclareceu sobre a operação (drenagem torácica) Sim = 0,5 Não esclareceu = 0,0
05	Esclareceu que o tratamento inicial é conservador, com drenagem torácica para retirada do líquido pleural e DIETA para o quadro (via oral, pobre em gordura <u>OU</u> jejum oral + dieta parenteral total) Sim (os 3) = 1,0 Sim (apenas 2) = 0,5 Não esclareceu = 0,0
06	a) Esclareceu sobre a necessidade de internação hospitalar. Sim = 0,5 Não = 0,0 b) Esclareceu sobre a necessidade de anestesia local, na região de introdução do dreno torácico. Sim = 0,5 Não = 0,0
07	Esclareceu sobre o tempo do tratamento conservador (no máximo, 14 dias). Sim (máximo 14 dias) = 1,0 Sim (entre 7 e 13 dias) = 0,5 Não esclareceu = 0,0
08	Esclareceu sobre a necessidade de cirurgia, no caso de persistência do débito quíloso pelo dreno torácico. Sim = 1,0 Não = 0,0
09	Esclareceu sobre as possibilidades cirúrgicas (ligadura do ducto torácico, por videotoracoscopia <u>OU</u> toracotomia, com ou sem pleurodese). Sim (as duas) = 1,0 Sim (apenas uma) = 0,5 Não esclareceu = 0,0
10	Ao final da consulta, perguntou ao paciente se todas as suas dúvidas foram esclarecidas. Sim = 1,0 Não = 0,0



1. Anemia ferropriva

DIAGNÓSTICO

- Hemograma com anemia microcítica e hipocrômica.
- Ferritina < 10 ng%
- Ferro sérico < 30mcg%, o que denota baixo estoque.

TRATAMENTO

- Suporte nutricional
- Reposição de ferro, preferencialmente por via oral: 900mg/dia (180mg de ferro elementar), divididos em 3 tomadas.
- A transfusão de hemácias deverá ser reservada para pacientes com sintomas que denotam grave hipóxia tecidual.

2. Anemia megaloblástica

Pode ser causada por deficiência de vitamina B12 ou ácido fólico, que ocorre por baixa ingestão (deficiência de folato) ou por impacto na absorção, como é o caso da anemia perniciosa (deficiência de vitamina B12).

DIAGNÓSTICO

- Neutrófilos plurisegmentares no sangue periférico.
- Pancitopenia.
- Dosagem de ácido fólico e vitamina B12.
- Dosagens séricas de ácido metilmalônico e homocisteína são usadas para confirmação diagnóstica.

TRATAMENTO

- Investigar as principais causas da deficiência de ácido fólico: nutricional, má absorção intestinal anticonvulsivantes, trimetopim e álcool. e uso de pirimetamina,
- Tratar com ácido fólico via oral, 5 mg/dia via oral e/ou vitamina B12 intramuscular.

3. Talassemia

É uma doença hereditária resultante de um defeito genético na síntese de uma ou mais cadeias globínicas da hemoglobina. Há dois principais tipos de talassemia - alfa (cromossomo 11) e beta (cromossomo 16).

DIAGNÓSTICO

- Hemograma com microcitose, hipocromia e reticulócitos aumentados
- A eletroforese de hemoglobina apresenta elevação da hemoglobina A2 nas beta-talassemias.

TRATAMENTO

- O tratamento varia de simples observação e acompanhamento, nas formas mais brandas (alfa talassemia ou beta talassemia minor), até transfusões sanguíneas frequentes e esplenectomia, nas formas mais severas (beta talassemia major).

4. ANEMIA FALCIFORME

Ocorre por mutação que substitui o ácido glutâmico por valina na posição 6 da cadeia β da globina. A hemácia com a globina mutante quando desoxigenada torna a clássica forma de foice, perdendo a flexibilidade necessária para atravessar os pequenos capilares. Os heterozigotos para a mutação apresentam uma entidade benigna (traço falciforme), sem ocorrência de anemia ou obstrução vascular.

DIAGNÓSTICO

- Anemia crônica, crises de dor osteoarticular, icterícia e história familiar frequentemente positiva.

- Eletroforese de hemoglobina que detecta a presença da hemoglobina mutante (Hemoglobina S).

TRATAMENTO

- Transfusões com concentrado de hemácias lavadas nos casos de hemoglobina $< 7g\%$.
- Evitar a ocorrência de fatores que precipitam a crise falcêmica, como desidratação, acidose, hipotensão arterial, hipoxemia e infecção.

SEMANA 14: ARBOVIROSES/DENGUE

Quadro clínico: Cefaleia, Dor retroorbitária, Mialgia, Exantema, Febre alta, Artralgia.

- Fase crítica:

S: sangramento das mucosas

I: irritabilidade

L: líquido acumulado

V: vômitos persistentes

A: abdome doloroso

H: hipotensão postural

H: hepatomegalia

H: hematócrito elevado

- Fase grave:

- Taquicardia.
- Extremidades distais frias.
- Pulso fraco e filiforme.
- Enchimento capilar lento (> 2 segundos).
- Pressão arterial convergente (< 20 mmHg).
- Oligúria ($< 1,5$ ml/kg/h).
- Hipotensão arterial.
- Cianose.

Exames complementares:

- A) Prova do laço:

1. Verificar a pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) e calcular o valor médio pela fórmula $(PAS + PAD)/2$.

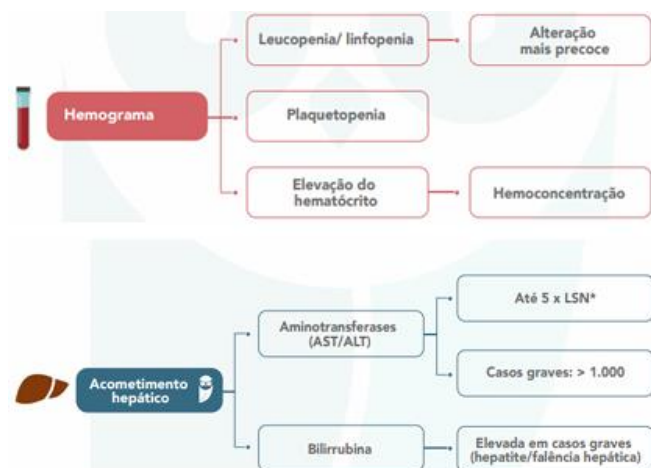
2. Insuflar o manguito até o valor médio e manter durante cinco minutos em adultos e três minutos em crianças.

3. Desenhar um quadrado com 2,5 cm de lado no antebraço e contar o número de petéquias formadas em seu interior. A prova será positiva se houver 20 ou mais petéquias em adultos e 10 ou mais em crianças. Quando positiva, o paciente passa a ser do grupo B da dengue.

B) Exame sorológico: O exame sorológico utiliza o método ELISA. Detecta anticorpos IgM e deve ser solicitado a partir do sexto dia após o início dos sintomas. Esse é o método mais frequentemente empregado para diagnóstico de dengue.

C) PCR/NR1: Exames que detectam o vírus devem utilizar amostras coletadas até o quinto dia de sintomas. Pesquisa do antígeno NS1.

D) Exames laboratoriais:



CLASSIFICAÇÃO E TRATAMENTO:

A primeira pergunta: **tem sinais de alarme?**

Letargia e irritabilidade.

Vômitos persistentes.

Hipotensão postural/lipotímia.

Sangramento de mucosas.

Acúmulo de líquidos.

Hepatomegalia > 2 cm do rebordo.

Dor abdominal intensa e contínua.

Não

Sim

A

B

C

D

SEM sinais de alarme

Presença de comorbidades?

> 65 anos

DM

HAS

DRC

DPOC

Gestantes

Contexto social de risco?

Prova do laço positiva?

Se NÃO para todas elas

Se SIM para alguma delas

A

B

SEM sinais de alarme, comorbidades, risco social e prova do laço negativa

A

1 **Hidratação oral**
60 mL/kg/dia – 1/3 SRO / 2/3 líquidos.

2 Sintomáticos.

3 Sinais de alarme e quando surgem.

4 Não usar AINEs/corticoides.

5 Usar repelentes durante a infecção.

6 Atenção aos usuários de AAS/Clopi.

SEM sinais de alarme e COM comorbidades OU risco social OU prova do laço positiva

B

1 Solicitar exames para avaliar compensação de comorbidades. Se descompensadas, considerar internar!

2 Solicitar um hemograma e hidrata enquanto aguarda.

Hematócrito normal

Hemoconcentração

A

C

COM sinais de alarme SEM sinais de choque

C

1 Solicitar exames: hemograma, PT e frações e transaminases. Outros SN.

2 Confirmação etiológica é importante.

3 Hidratação EV.

10 mL/kg/h por 2 h

Se sem melhora clínica/laboratorial

Repetir até 3x!

• Segue sem melhora. **D**

• Se melhora. Fase de manutenção.

COM sinais de alarme COM sinais de choque

D - UTI

1 Solicitar exames: hemograma, PT e frações e transaminases. Outros SN.

2 Confirmação etiológica é importante.

3 Hidratação EV.

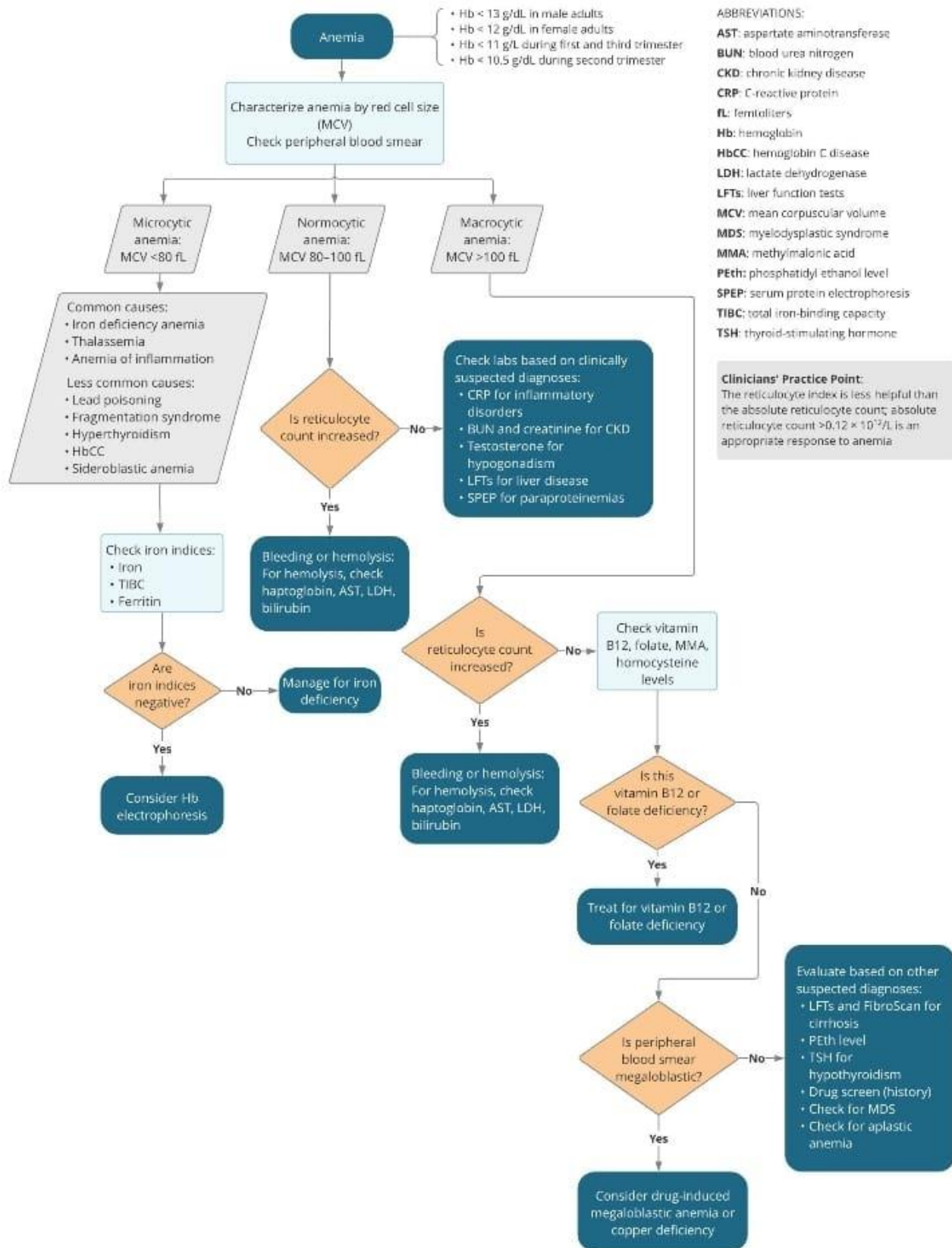
20mL/kg em 20min

Reavaliar a cada 30min

• Segue sem melhora. Avaliar!

• Se melhora. Fase de expansão do C

Anemia in Adults Diagnosis



REFERENCES: Hematol Oncol Clin North Am. 2017 Dec;31(6):1045–1060 • Med Clin North Am. 2017 Mar;101(2):263–284 • Hematol Oncol Clin North Am. 2012 Apr;26(2):205–230

Version 1.2 | © EBSCO Industries, Inc. All rights reserved.